



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN GERIATRI
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor: 001.4/I-PDM/DIR/I/2026

Tentang Pedoman Pelayanan Geriatri

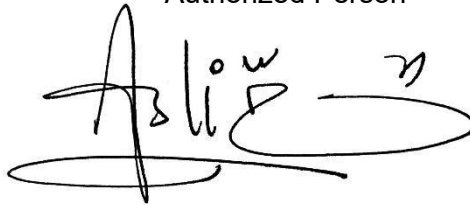
Disusun oleh :

Penanggung jawab



dr. Heriyatmo, Sp. PD

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah M.Kes. AFP

Ditetapkan oleh :

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pelayanan Geriatri Rumah Sakit Prima Husada ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Peningkatan angka harapan hidup masyarakat berdampak pada meningkatnya jumlah pasien lanjut usia dengan berbagai permasalahan kesehatan yang kompleks, seperti multimorbiditas, sindrom geriatri, penurunan fungsi kognitif, serta kebutuhan dukungan sosial dan keluarga. Kondisi tersebut menuntut adanya pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, multidisiplin, serta berkesinambungan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri di Rumah Sakit Prima Husada Malang, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta optimalisasi kualitas hidup pasien geriatri melalui pendekatan Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) dan tata laksana multidisiplin.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, serta kebutuhan pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan akan dilakukan secara berkala demi peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam memberikan pelayanan geriatri yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 01 Januari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN TIM GERIATRI

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
2. dr. Resti Lestantini, M. Kes

PELAKSANA

1. dr. Heriyatmo, Sp. PD
2. dr. Amanda Firmandani
3. dr. Moch Safri Darmaputra
4. Ns. Isa Ariyanti, S.Kep
5. Ns. Risma Indra Setiyani, S.Kep
6. Billy Mavino Perkasa, Amd.Kep
7. Devi Kartika Sari, Amd.Kep
8. Ns. Saudah, S.Kep
9. Fatimatuzzahro, Amd.Kep
10. Yayuk Rinika, Amd.Kep
11. Ns. Ani Dwi Karima, S.Kep
12. Ns. Dewi Eka Yanti, S.Kep
13. Fifi Wahyuningsih, Amd. Keb
14. Ns. Annisa Fitri, S.Kep
15. Saghita Puspitasari, Amd. Kep
16. Diryati Barin Putri, S.Farm., Apt
17. Eka Firda Ristia Putri Suryanto, Amd. Gz
18. Dinar Sahara, Amd.Fis
19. Mokhammad Eriko Firdaus, S.Kom
20. Hury Markustinus, Amd.RMIK., S.MIK



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 001.4/I-PDM/DIR/I/2026**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN GERIATRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia, diperlukan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan bagi pasien geriatri di Rumah Sakit Prima Husada;
- b. bahwa pasien geriatri memiliki karakteristik khusus berupa multimorbiditas, sindrom geriatri, gangguan fungsi, serta kebutuhan pelayanan multidisiplin sehingga memerlukan pedoman pelayanan yang terstandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Geriatri Rumah Sakit Prima Husada.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN GERIATRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan Geriatri adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien lanjut usia yang dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, dan



- berkesinambungan melalui pendekatan multidisiplin untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup pasien;
- (3) Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 - (4) Geriatri adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek Kesehatan dan kedokteran pada warga Lanjut Usia termasuk pelayanan Kesehatan kepada Lanjut Usia dengan mengkaji semua aspek Kesehatan berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
 - (5) Pasien Geriatri (Lanjut Usia/Lansia) adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan/atau memiliki sindrom geriatri, penyakit kronis multipel, penurunan fungsi organ, gangguan kognitif, atau masalah psikososial yang memerlukan pendekatan pelayanan khusus;
 - (6) Pelayanan Rawat Jalan Geriatri adalah pelayanan geriatri yang diberikan kepada pasien tanpa perawatan inap dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
 - (7) Pelayanan Rawat Inap Geriatri adalah pelayanan kepada pasien geriatri yang dirawat di ruang perawatan rumah sakit dengan standar keselamatan dan fasilitas yang ramah lansia (*age-friendly hospital*).

BAB II STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2 Pembentukan Tim Pelayanan Geriatri

- (1) Rumah Sakit membentuk Tim Pelayanan Geriatri melalui Surat Keputusan Direktur;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dokter spesialis penyakit dalam;
 - b. Dokter spesialis rehabilitasi;
 - c. Dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - d. Dokter spesialis lainnya sesuai dengan jenis penyakit pasien geriatri;
 - e. Dokter;
 - f. Perawat yang telah mengikuti pelatihan keperawatan gerontik atau pelatihan keterampilan intelegensia;
 - g. Apoteker;
 - h. Tenaga gizi;
 - i. Fisioterapis;
- (3) Struktur dan keanggotaan Tim Geriatri ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3 Tugas dan Fungsi Tim Pelayanan Geriatri

- (1) Tim Pelayanan Geriatri bertugas menyelenggarakan pelayanan geriatri secara komprehensif dan terintegrasi;
- (2) Tim berfungsi:
 - a. Melakukan Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK);
 - b. Menyusun rencana pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan intervensi sesuai kompetensi;



- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan;
- e. Menyusun perencanaan pemulangan pasien (discharge planning).

BAB III STANDAR FASILITAS

Pasal 4 Standar Bangunan

- (1) Bangunan pelayanan geriatrik tingkat lengkap terdiri atas :
 - a. Ruang pendaftaran;
 - b. Ruang tunggu;
 - c. Ruang pemeriksaan;
 - d. Ruang perawatan geriatri
 - e. Ruang tim terpadu geriatri;
- (2) Ruang perawatan geriatri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruang rawat inap dan ruang fisioterapi

Pasal 5 Standar peralatan

- (1) Peralatan pada pelayanan geriatri meliputi peralatan untuk pemeriksaan, terapi, dan Latihan;
- (2) Jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai tingkatan pelayanan geriatri;
- (3) Jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Kebutuhan pelayanan;
 - b. Rata-rata jumlah kunjungan setiap hari;
 - c. Angka rata-rata pemakaian tempat tidur/Bed Occupancy Rate (BOR) bagi pelayanan rawat inap;
 - d. Evaluasi kemampuan alat dan efisiensi penggunaan alat;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA LAKSANA

Pasal 6 Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarananya;
- (2) Tingkat pelayanan geriatri yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Prima Husada yaitu tingkat lengkap yang terdiri dari rawat jalan, rawat inap akut dan home care;
- (3) Setiap pasien geriatri dilakukan skrining awal risiko geriatri;
- (4) Hasil assesmen menjadi dasar penyusunan rencana perawatan individual;
- (5) Rumah sakit melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi



- kegiatan pelayanan geriatri;
(6) Rumah sakit melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan geriatri.

BAB V PROMOSI DAN EDUKASI

Pasal 7 Promosi dan Edukasi Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut Usia

1. Rumah sakit membuat program PKRS terkait pelayanan Kesehatan warga lanjut usia di Masyarakat (*hospital based community geriatric service*);
2. Rumah sakit memberikan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit (*hospital based community geriatric service*);
3. Rumah sakit melaksanakan kegiatan sesuai program dan tersedia leaflet atau alat bantu kegiatan (brosur, leaflet, dan lain-lainnya);
4. Rumah sakit melakukan evaluasi dan membuat laporan kegiatan pelayanan secara berkala.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8
Pada saat peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, peraturan direktur rumah sakit prima husada nomor tentang pedoman pelayanan geriatri dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Malang, 01 Januari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
PERATURAN DIREKTUR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Batas Operasional	3
BAB II STANDAR KETENAGAAN	6
2.1 Struktur Organisasi Tim terpadu Geriatri	6
2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	6
BAB III STANDAR FASILITAS	9
3.1 Standar Bangunan	9
3.2 Standar Peralatan	10
BAB VI TATALAKSANA GERIATRI	12
4.1 Prinsip Pelayanan	12
4.2 Prosedur Pelayanan Geriatri	12
BAB V PROMOSI DAN EDUKASI	14
5.1 Ruang Lingkup Promosi dan Edukasi	14
5.2 Tatalaksana Promosi dan Edukasi	14
BAB VI PENUTUP	16

DAFAR TABEL

Tabel 2.2.1 Ketenagaan Rawat Jalan Geriatri	6
Tabel 5.1.1 Alur Pelayanan Geriatri	13

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 001.4/I-PDM/DIR/I/2026
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
GERIATRI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN GERIATRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peningkatan angka harapan hidup dan pergeseran struktur demografi di Indonesia telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Kondisi ini berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang spesifik, komprehensif, dan berkesinambungan bagi populasi geriatri. Lansia memiliki karakteristik khusus berupa penurunan fungsi fisiologis, adanya penyakit kronis multipel, sindrom geriatri, gangguan kognitif, serta permasalahan psikososial yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan yang berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan geriatri yang bermutu, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pelayanan geriatri tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif dengan pendekatan multidisiplin melalui Asesmen Geriatri Komprehensif (Comprehensive Geriatric Assessment/CGA).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014, rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan klasifikasi dan kemampuan rumah sakit, termasuk pembentukan Tim Terpadu Geriatri, penyediaan sarana prasarana yang ramah lansia, serta pelaksanaan pelayanan yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS/STARKES), pelayanan geriatri harus memenuhi prinsip peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen risiko, tata kelola klinis (clinical governance), serta pelayanan berfokus pada pasien (patient centered care). Standar akreditasi juga menekankan pentingnya integrasi pelayanan antar unit, kesinambungan asuhan (continuity of care), pencegahan risiko jatuh, pengelolaan polifarmasi, serta koordinasi perencanaan pemulangan pasien (discharge planning) pada pasien geriatri.

Rumah Sakit Prima Husada sebagai institusi pelayanan kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien, termasuk dalam pelayanan kepada pasien geriatri. Seiring meningkatnya jumlah pasien lansia yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada, diperlukan suatu pedoman tertulis yang menjadi acuan dalam

penyelenggaraan pelayanan geriatri agar:

1. Pelayanan dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi.
2. Terpenuhi standar regulasi dan akreditasi rumah sakit.
3. Terjamin keselamatan dan hak pasien geriatri.
4. Terlaksana peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
5. Tersedia kejelasan peran dan tanggung jawab Tim Terpadu Geriatri

Pedoman Pelayanan Geriatri Rumah Sakit Prima Husada ini disusun sebagai landasan operasional bagi seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien geriatri secara komprehensif, multidisiplin, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi yang berlaku.

Dengan tersusunnya pedoman ini, diharapkan pelayanan geriatri di Rumah Sakit Prima Husada dapat berjalan optimal, terstandar, dan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia secara holistik.

1.2 TUJUAN

1. Tujuan Umum

Terselenggaranya pelayanan geriatri tingkat lengkap di rumah sakit yang bermutu, efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada pasien (*patient centered care*) guna meningkatkan derajat kesehatan, mempertahankan kemandirian, serta meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia sesuai standar akreditasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri tingkat lengkap yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
- b. Menjamin terselenggaranya Asesmen Geriatri Komprehensif (*Comprehensive Geriatric Assessment/CGA*) secara sistematis dan terdokumentasi.
- c. Mengatur pembentukan, peran, dan tanggung jawab Tim Terpadu Geriatri dalam memberikan pelayanan multidisiplin yang terintegrasi.
- d. Menjamin penerapan prinsip keselamatan pasien geriatri, termasuk:
 - 1) Pencegahan risiko jatuh
 - 2) Pencegahan dekubitus
 - 3) Pengelolaan polifarmasi
 - 4) Pencegahan delirium
 - 5) Pencegahan infeksi terkait pelayanan kesehatan
- e. Menjamin terselenggaranya kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) melalui koordinasi antar unit pelayanan, termasuk perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*).
- f. Menyediakan standar sarana, prasarana, dan lingkungan rumah sakit yang ramah lansia (*age-friendly hospital*).
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan geriatri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- h. Mendukung pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit terkait pelayanan kelompok risiko tinggi dan pelayanan geriatri.
- i. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan program peningkatan mutu pelayanan geriatri secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

- j. Menjamin perlindungan hak pasien geriatri, termasuk hak atas informasi, persetujuan tindakan medis (*informed consent*), privasi, dan pendampingan keluarga.

1.3 RUANG LINGKUP

1. Pasien

- a. Pasien lanjut usia (≥ 60 tahun) yang datang ke rumah sakit dalam kondisi:
 - 1) Penyakit akut
 - 2) Penyakit kronis multipel
 - 3) Eksaserbasi penyakit kronis
 - 4) Kondisi terminal
- b. Pasien lansia dengan sindrom geriatri, antara lain:
 - 1) Risiko jatuh atau riwayat jatuh berulang
 - 2) Gangguan mobilitas dan imobilisasi
 - 3) Gangguan kognitif (demensia, delirium)
 - 4) Inkontinensia
 - 5) Malnutrisi
 - 6) Polifarmasi
 - 7) Dekubitus
- c. Pasien lansia dengan ketergantungan fungsional sebagian atau total yang memerlukan Asesmen Geriatri Komprehensif (CGA).
- d. Pasien lansia dengan masalah psikososial, termasuk isolasi sosial, depresi, atau kebutuhan dukungan keluarga.

2. Pelayanan

- a. Terlaksananya pelayanan geriatri tingkat lengkap yang meliputi:
 - 1) Pelayanan rawat jalan geriatri
 - 2) Pelayanan rawat inap geriatri
 - 3) Pelayanan konsultasi geriatri antar unit
 - 4) Pelayanan rehabilitasi medik geriatri
 - 5) Pelayanan paliatif pada pasien lansia
- b. Terlaksananya Asesmen Geriatri Komprehensif secara multidisiplin dan terdokumentasi.
- c. Terwujudnya kesinambungan pelayanan (*continuity of care*), termasuk discharge planning dan rujukan.
- d. Terpenuhinya standar keselamatan pasien geriatri sesuai elemen penilaian akreditasi.

1.4 BATASAN OPERASIONAL

1. Batasan Usia Pasien Geriatri

- a. Pasien geriatri adalah pasien berusia ≥ 60 tahun
- b. Pasien < 60 tahun dengan kondisi frailty, multimorbiditas, atau disabilitas dapat dipertimbangkan masuk kategori geriatri berdasarkan pertimbangan klinis DPJP

2. Kriteria Pasien Geriatri Yang Dilayani

Pelayanan geriatri diberikan kepada pasien dengan:

- a. Multimorbiditas (≥ 2 penyakit kronis)
- b. Penurunan status fungsional (ketergantungan ADL/IADL).
- c. Gangguan kognitif (demensia, delirium).

-
- d. Risiko jatuh tinggi.
 - e. Polifarmasi (≥ 5 obat rutin).
 - f. Masalah nutrisi (malnutrisi / risiko malnutrisi).
 - g. Kondisi sosial kompleks (lansia terlantar / tanpa pendamping).
3. Batasan Jenis Pelayanan
- Pelayanan geriatri di rumah sakit prima husada meliputi :
- a. Rawat jalan
 - 1) Asesmen awal dan lanjutan
 - 2) Pengkajian Geriatri Komprehensif (CGA)
 - 3) Evaluasi terapi dan polifarmasi
 - 4) Edukasi pasien dan keluarga
 - b. Rawat inap geriatri
 - 1) Perawatan kasus akut dan kompleks
 - 2) Monitoring resiko jatuh, delirium, dekubitus
 - 3) Perencanaan pemulangan
 - c. Rehabilitasi Medik
 - 1) Fisioterapi
 - 2) Mobilisasi
 - 3) Evaluasi alat bantu
 - d. Pelayanan Paliatif
 - 1) Manajemen nyeri
 - 2) Perawatan suportif
 - 3) Pendampingan ahir hayat
4. Batasan kewenangan tenaga kesehatan
- a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) bertanggung jawab atas diagnosis dan terapi medis.
 - b. Perawat geriatri melakukan asesmen keperawatan geriatri dan intervensi sesuai kewenangan.
 - c. Apoteker melakukan review obat dan evaluasi interaksi obat.
 - d. Ahli gizi melakukan asesmen nutrisi dan intervensi diet.
 - e. Fisioterapis melakukan asesmen dan terapi rehabilitatif.
 - f. Setiap tindakan harus sesuai standar profesi dan regulasi yang berlaku
5. Batasan Sarana dan Prasarana
- a. Pelayanan geriatri dilaksanakan pada area yang memenuhi kriteria ramah lansia:
 - b. Lantai tidak licin
 - c. Pencahayaan cukup
 - d. Handrail di area risiko
 - e. Tempat tidur dengan pengaman
 - f. Toilet ramah lansia
 - g. Alat bantu mobilisasi
6. Batasan Rujukan
- Pasien dirujuk apabila:
- a. Membutuhkan pelayanan subspesialis yang tidak tersedia.
 - b. Membutuhkan fasilitas intensif khusus yang tidak dimiliki RS.
 - c. Membutuhkan pelayanan lanjutan jangka panjang di fasilitas lain.
7. Batasan Dokumentasi
- a. Seluruh asesmen dan intervensi wajib terdokumentasi dalam rekam medis.
 - b. Pengkajian risiko jatuh dan status fungsional wajib diisi pada pasien geriatri.
 - c. Discharge planning wajib terdokumentasi sebelum pasien pulang
8. Batasan Monitoring dan Evaluasi

-
- a. Indikator mutu yang dimonitor
 - b. Angka kejadian jatuh pasien lansia
 - c. Angka luka tekan
 - d. Kepatuhan asesmen CGA
 - e. Angka readmisi ≤ 30 hari

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Struktur Organisasi Tim Terpadu Geriatri

Tabel 2.2.1 Struktur Organisasi Tim Terpadu Geriatri

Ketua Tim	:	dr. Heriyatmo,Sp. PD
Sekretaris	:	Ns. Isa Ariyanti, S.Kep
Anggota		
1. Dokter Umum	:	dr. Amanda Firmandani dr. Moch. Safri Darmaputra
2. Apoteker	:	Diryati Barin Putri, S. Farm. Apt
3. Perawat	:	1. Ns. Risma Indra Setiyani, S.Kep 2. Billy Mavino Perkasa, Amd.Kep 3. Devi Kartika Sari, Amd.Kep 4. Ns. Saudah, S.Kep 5. Fatimatuzzahro, Amd.Kep 6. Yayuk Rinika, Amd.Kep 7. Ns. Ani Dwi Karima, S.Kep 8. Ns. Dewi Eka Yanti, S.Kep 9. Fifi Wahyuningsih, Amd. Keb 10. Ns. Annisa Fitri, S.Kep 11. Saghita Puspitasari, Amd. Kep
4. Tenaga Gizi	:	Eka Firda Ristia Putri Suryanto, Amd. Gz
5. Fisioterapis	:	Dinar Sahara, Amd.Fis
6. PKRS	:	Mukhammad Eriko Firdaus, S. Kom
7. Rekam Medis Pendaftaran	:	Hury Markustinus, Amd.RMIK., S.MIK

2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Ketua Tim Pelayanan Geriatri

a. Uraian Tugas

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan geriatri.
- 2) Menetapkan kebijakan teknis pelayanan geriatri bersama manajemen rumah sakit.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK).
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan rencana asuhan pasien geriatri secara multidisiplin.
- 5) Memimpin rapat tim geriatri secara berkala.
- 6) Melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan geriatri.
- 7) Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelayanan pasien geriatri.

b. Tanggung Jawab

- 1) Terlaksananya pelayanan geriatri sesuai standar.
- 2) Terjaminnya keselamatan pasien geriatri.
- 3) Terlaksananya koordinasi tim multidisiplin.
- 4) Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan geriatri

c. Wewenang

- 1) Memberikan arahan kepada anggota tim geriatri.
- 2) Menetapkan rencana pelayanan pasien bersama tim.

-
- 3) Meminta konsultasi dari tenaga kesehatan lain.
 - 4) Memberikan rekomendasi kebijakan pelayanan geriatri kepada direktur
2. Dokter Spesialis/ Dokter Umum
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien geriatri.
 - 2) Menegakkan diagnosis medis.
 - 3) Menyusun rencana terapi medis.
 - 4) Melakukan asesmen medis dalam AGK.
 - 5) Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.
 - 6) Melakukan monitoring perkembangan pasien
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Ketepatan diagnosis dan terapi.
 - 2) Keselamatan pasien selama pelayanan medis.
 - 3) Dokumentasi pelayanan medis di rekam medis
 - c. Wewenang
 - 1) Menetapkan diagnosis medis.
 - 2) Menentukan terapi medis.
 - 3) Meminta pemeriksaan penunjang.
 - 4) Melakukan konsultasi dengan dokter lain
 3. Perawat
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan pengkajian keperawatan geriatri.
 - 2) Mengidentifikasi risiko pasien geriatri (jatuh, dekubitus, delirium, dll).
 - 3) Menyusun rencana asuhan keperawatan.
 - 4)
 - 5) Melaksanakan tindakan keperawatan.
 - 6) Melakukan pemantauan kondisi pasien.
 - 7) Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Terlaksananya asuhan keperawatan yang aman dan bermutu.
 - 2) Ketepatan dokumentasi keperawatan.
 - 3) Keselamatan pasien selama asuhan keperawatan
 - c. Wewenang
 - 1) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi.
 - 2) Mengidentifikasi masalah keperawatan.
 - 3) Mengusulkan intervensi kepada tim
 4. Apoteker
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan asesmen penggunaan obat pasien geriatri.
 - 2) Mengidentifikasi potensi interaksi obat.
 - 3) Mengidentifikasi potensi efek samping obat.
 - 4) Memberikan rekomendasi terapi obat kepada dokter.
 - 5) Memberikan edukasi penggunaan obat
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Keamanan penggunaan obat pasien geriatri.
 - 2) Ketepatan pengelolaan obat.
 - 3) Dokumentasi pelayanan farmasi klinik
 - c. Wewenang
 - 1) Melakukan review terapi obat.
 - 2) Memberikan rekomendasi terapi obat.
 - 3) Memberikan edukasi penggunaan obat
 5. Ahli Gizi

-
- a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan asesmen status gizi pasien geriatri.
 - 2) Menentukan diagnosis gizi.
 - 3) Menyusun rencana intervensi gizi.
 - 4) Memantau status gizi pasien.
 - 5) Memberikan edukasi gizi.
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Ketepatan intervensi gizi.
 - 2) Peningkatan status gizi pasien.
 - 3) Dokumentasi pelayanan gizi
 - c. Wewenang
 - 1) Menentukan intervensi gizi.
 - 2) Memberikan edukasi gizi.
 - 3) Memberikan rekomendasi diet kepada tim
6. Fisioterapis
- a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan asesmen fungsi fisik pasien
 - 2) Menentukan program rehabilitasi.
 - 3) Melaksanakan terapi fisik.
 - 4) Mencegah penurunan fungsi fisik.
 - 5) Melakukan evaluasi hasil terapi
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Peningkatan atau mempertahankan fungsi pasien.
 - 2) Keamanan selama terapi
 - c. Wewenang
 - 1) Menentukan program fisioterapi.
 - 2) Melaksanakan tindakan fisioterapi.

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Standar Bangunan

1. Konstruksi bangunan

a. Jalan

Jalan menuju ke pelayanan geriatri harus cukup kuat, rata, tidak licin serta disediakan jalur khusus untuk pasien/pengunjung dengan kursi roda.

b. Pintu

Pintu harus cukup lebar untuk memudahkan pasien/pengunjung lewat dengan kursi roda atau tempat tidur. Lebar pintu sebaiknya 120 cm terdiri dari pintu 90 cm dan pintu 30 cm

c. Listrik

Daya listrik harus cukup dengan cadangan daya bila suatu saat memerlukan tambahan penerangan sehingga diperlukan stabilisator untuk menjamin stabilitas tegangan, dilengkapi dengan generator listrik.

d. Penerangan

Penerangan lorong dan ruang harus terang namun tidak menyilaukan. Setiap lampu penerangan di atas tempat tidur harus diberi penutup, agar tidak menyilaukan.

e. Lantai

Lantai harus rata, mudah dibersihkan tetapi tidak licin, bila ada undakan atau tangga harus jelas terlihat dengan warna ubin yang berbeda untuk mencegah jatuh.

f. Langit-langit

Langit-langit harus kuat dan mudah dibersihkan.

g. Dinding

Dinding harus permanen dan kuat dan sebaiknya di cat berwarna terang. Khusus untuk dinding ruang latihan, sebaiknya dipilih warna yang bersifat memberi semangat dan di sepanjang dinding, terdapat pegangan yang kuat sebaiknya terbuat dari kayu (hand rail).

h. Ventilasi

Semua ruangan harus diberi cukup ventilasi. Ruangan yang menggunakan pendingin/air condition harus dilengkapi cadangan ventilasi untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kematian arus listrik.

i. Kamar mandi dan WC

Kamar mandi menggunakan kloset duduk dengan pegangan di sebelah kanan dan kirinya. Shower dilengkapi dengan tempat duduk dan pegangan. Gagang shower harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien dalam posisi duduk. Demikian pula tempat sabun harus diletakkan sedemikian agar mudah dijangkau pasien. Tersedia bel untuk meminta bantuan dan pintu membuka keluar.

j. Air

Penyediaan air untuk kamar mandi, WC, cuci tangan harus cukup dan memenuhi persyaratan. Semua fasilitas gedung dan lingkungan harus mengacu kepada pedoman Pekerjaan Umum tentang standar teknis aksesibilitas gedung dan lingkungan

k. Pada dinding-dinding tertentu harus diberi pengaman dan kayu atau aluminium (leuning) yang berfungsi sebagai pegangan bagi pasien pada saat berjalan serta untuk melindungi dinding dari benturan kursi roda.

-
- l. Agar dihindari sudut-sudut yang tajam pada dinding atau bagian tertentu untuk menghindari kemungkinan terjadinya bahaya/trauma.
 - m. Disediakan wastafel pada setiap ruangan pemeriksaan, pengobatan dan ruangan yang lain
2. Kebutuhan ruangan
- a. Ruang pendaftaran administrasi
Ruangan ini harus cukup luas untuk penempatan meja tulis, lemari arsip untuk penyimpanan dokumen medik pasien. Letaknya dekat dengan ruang tunggu, sehingga mudah dilihat oleh pasien yang baru datang.
 - b. Ruang tunggu
Harus bersih dan cukup luas, aman dan nyaman, baik untuk pasien dari luar ataupun dari bangsal yang menggunakan kursi roda atau tempat tidur.
 - c. Ruang periksa
Ruangan ini dekat dengan ruang pendaftaran serta dilengkapi dengan fasilitas dan alat-alat pemeriksaan. Ruangan terdiri dari:
 - 1) Ruang periksa perawat geriatri dan sosial medik untuk melakukan anamnesis;
 - 2) Ruang periksa dokter/tim geriatri;
 - 3) Wc dan kamar mandi; dan
 - 4) Ruang diskusi tim geriatri atau pertemuan dengan keluarga pasien (family meeting).
 - d. Ruang bangsal geriatri akut Ruang ini harus cukup luas dan setidaknya harus mempunyai fasilitas:
 - 1) Bangsal perawatan terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan bel terpasang disetiap dinding tempat tidur;
 - 2) Ruang semi intensif dengan minimal 1 (satu) tempat tidur, terbagi atas laki-laki dan perempuan (disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan);
 - 3) Ruang dokter;
 - 4) Ruang rehabilitasi akut;
 - 5) Ruang perawatan, dengan lokasi yang memungkinkan untuk perawat melihat semua pasien yang sedang dalam perawatan;
 - 6) Kamar mandi dan wc yang jumlahnya sesuai dan dilengkapi dengan fasilitas dan persyaratan untuk pasien lanjut usia;
 - 7) Kamar mandi/wc khusus untuk perawat dan pengunjung;
 - 8) Ruang rapat kecil;
 - 9) Gudang.
 - e. Ruang tenaga staf dan ruang pertemuan, terdiri dari:
 - 1) ruang ketua tim;
 - 2) ruang anggota;
 - 3) 1 (satu) ruang pertemuan untuk tim;
 - 4) ruang istirahat karyawan dan pantry;
 - 5) kamar kecil untuk karyawan

3.2 Standar Peralatan

Peralatan pada pelayanan geriatri meliputi peralatan untuk pemeriksaan, terpa dan latihan. Jenis peralatan pelayanan geriatri tingkat sederhana terdiri dari :

- 1. Ruang periksa
 - a. Tempat tidur pasien
 - b. 1 set alat pemeriksaan fisik
 - c. EKG
 - d. Light box
 - e. Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan

-
- f. Instrumen penilaian kognitif, psikologi, psikiatri
2. Ruang Rawat Inap
 - a) Tempat tidur pasien
 - b) Oksigen
 - c) Suction
 - d) Ekg
 - e) Timbangan
 - f) Kursi roda
 - g) Blue bag
 3. Ruang Fisioterapi
 - a) Paralel bar
 - b) Kursi roda
 - c) Meja fisioterapi
 - d) Alat diatermi
 - e) TENS

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN GERIATRI

4.1 Prinsip Pelayanan

1. Pelayanan dilaksanakan secara multidisiplin dan terintegrasi.
2. Pelayanan berorientasi pada pasien (patient centered care).
3. Setiap pasien geriatri wajib menjalani skrining risiko geriatri.
4. Pelayanan mencakup rawat jalan, rawat inap akut, dan home care.
5. Setiap intervensi didasarkan pada Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK).

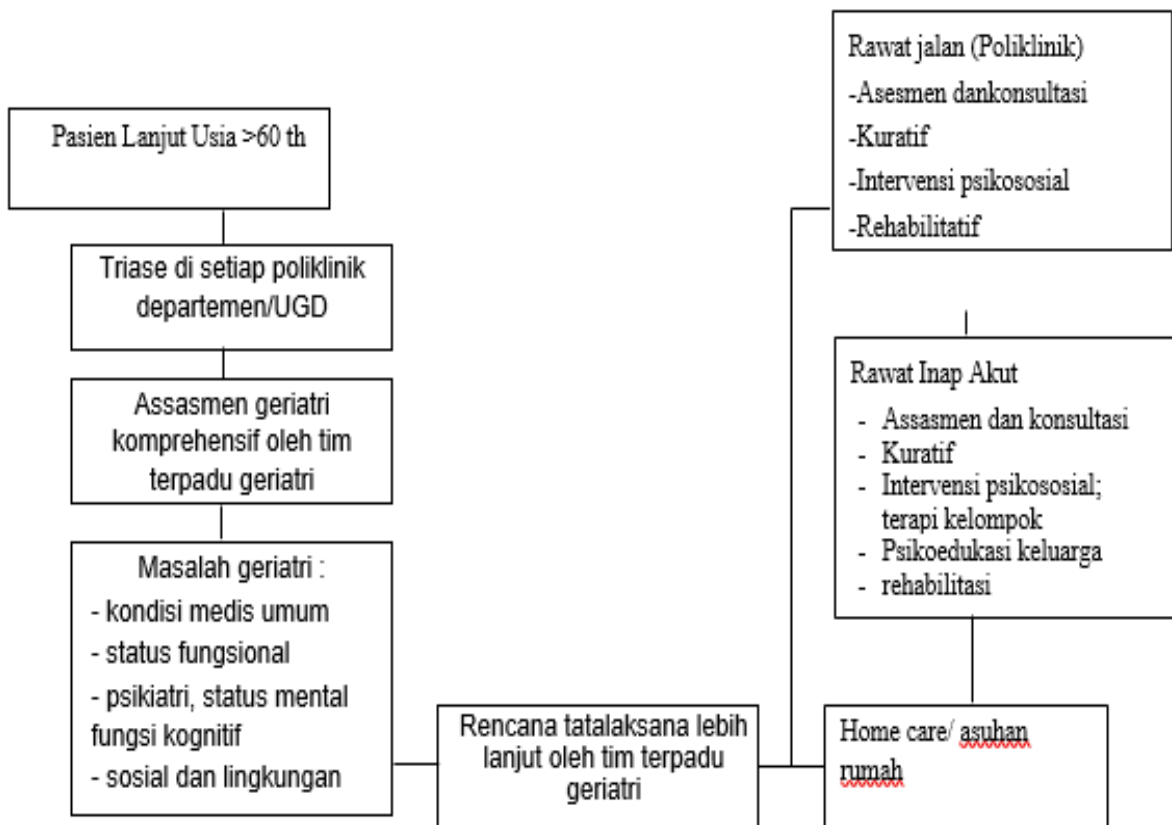
4.2 Prosedur Pelayanan Geriatri

1. Prosedur Skrining Awal Pasien Geriatri
 - a. Lakukan identifikasi pasien usia ≥ 60 tahun pada saat pendaftaran.
 - b. Lakukan skrining awal risiko geriatri meliputi:
 - 1) Risiko jatuh
 - 2) Status kognitif
 - 3) Status fungsional (ADL)
 - 4) Status nutrisi
 - 5) Risiko dekubitus
 - c. Catat hasil skrining dalam rekam medis.
 - d. Rujuk pasien dengan risiko tinggi kepada Tim Terpadu Geriatri untuk AGK.
2. Prosedur Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK)
 - a. Lakukan asesmen medis oleh dokter.
 - b. Lakukan asesmen keperawatan geriatri.
 - c. Lakukan asesmen fungsional (ADL/IADL)
 - d. Lakukan asesmen kognitif dan psikososial.
 - e. Lakukan asesmen nutrisi
 - f. Lakukan asesmen farmakoterapi (polifarmasi).
 - g. Dokumentasikan seluruh hasil asesmen dalam rekam medis.
 - h. Susun rencana perawatan individual (individual care plan).
3. Prosedur Pelayanan Rawat Jalan Geriatri
 - a. Lakukan registrasi dan verifikasi identitas pasien.
 - b. Lakukan skrining dan AGK sesuai indikasi.
 - c. Susun rencana terapi medis dan non-medis.
 - d. Berikan edukasi kepada pasien dan keluarga.
 - e. Tentukan jadwal kontrol dan tindak lanjut.
 - f. Dokumentasikan seluruh tindakan dalam rekam medis.
4. Prosedur Pelayanan Rawat Inap
 - a. Lakukan asesmen awal dalam 24 jam pertama perawatan.
 - b. Terapkan pencegahan risiko jatuh dan dekubitus.
 - c. Lakukan monitoring harian status fungsional dan kognitif.
 - d. Laksanakan visite tim multidisiplin secara berkala.
 - e. Laksanakan rehabilitasi dini (early mobilization).
 - f. Lakukan discharge planning sejak awal perawatan.
 - g. Edukasi keluarga sebelum pasien dipulangkan.
5. Prosedur Pelayanan Home Care Geriatri
 - a. Lakukan asesmen kelayakan home care sebelum pemulangan.
 - b. Susun rencana kunjungan rumah oleh tim.
 - c. Lakukan pelayanan medis, keperawatan, dan rehabilitasi sesuai kebutuhan.
 - d. Evaluasi kondisi pasien pada setiap kunjungan.

- e. Dokumentasikan pelayanan dalam rekam medis home care.
 - f. Rujuk kembali ke rumah sakit bila terjadi perburukan kondisi.
6. Monitoring dan evaluasi pelayanan
- a. Lakukan pertemuan tim (case conference) secara berkala.
 - b. Evaluasi pencapaian rencana perawatan individual.
 - c. Monitor indikator mutu pelayanan geriatri, meliputi:
 - 1) Angka kejadian jatuh
 - 2) Angka dekubitus
 - 3) Lama rawat pasien geriatri
 - 4) Re-admisi < 30 hari
 - d. Laporkan hasil evaluasi kepada Direktur secara periodik
7. Pelaporan
- a. Catat seluruh kegiatan pelayanan geriatri dalam sistem informasi rumah sakit
 - b. Susun laporan triwulanan pelayanan geriatri.
 - c. Laporkan pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Alur Pelayanan Geriatri Tingkat Lengkap

5.1.1 Alur Pelayanan Geriatri



BAB V

PROMOSI DAN EDUKASI

5.1 Ruang Lingkup Promosi dan Edukasi

1. Promosi Kesehatan (promotive)
 - a. Penuaan sehat (healthy aging)
 - b. Pencegahan penyakit degeneratif
 - c. Aktivitas fisik lansia
 - d. Nutrisi seimbang lansia
 - e. Pencegahan jatuh
 - f. Kepatuhan minum obat
2. Edukasi kuratif dan rehabilitative
 - a. Penjelasan diagnosis dan rencana terapi
 - b. Manajemen penyakit kronis
 - c. Pencegahan komplikasi
 - d. Latihan rehabilitasi mandiri
 - e. Edukasi penggunaan alat bantu
3. Edukasi paliatif dan home care
 - a. Perawatan di rumah
 - b. Pencegahan luka tekan
 - c. Tanda bahaya yang harus dirujuk
 - d. Dukungan psikososial keluarga

5.2 Tata Laksana Promosi dan Edukasi

1. Perencanaan program promosi
 - a. Identifikasi kebutuhan edukasi berdasarkan data penyakit geriatri.
 - b. Susun rencana tahunan promosi kesehatan geriatri.
 - c. Koordinasikan dengan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
 - d. Tentukan metode edukasi: individual, kelompok, media cetak, audiovisual, atau digital.
2. Pelaksanaan edukasi individu

Dilakukan pada pasien rawat jalan, rawat inap, dan home care

 - a. Identifikasi kebutuhan belajar pasien dan keluarga.
 - b. Gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
 - c. Gunakan media bantu (leaflet, gambar, video).
 - d. Libatkan keluarga dalam proses edukasi.
 - e. Gunakan metode teach back untuk memastikan pemahaman.
 - f. Dokumentasikan edukasi dalam rekam medis
3. Pelaksanaan edukasi kelompok
 - a. Tentukan tema edukasi sesuai kebutuhan lansia
 - b. Jadwalkan sesi edukasi rutin (misal: kelas lansia sehat).
 - c. Sampaikan materi oleh tim multidisiplin.
 - d. Berikan kesempatan tanya jawab.
 - e. Lakukan evaluasi pemahaman peserta.
 - f. Dokumentasikan kegiatan dalam laporan PKRS.
4. Edukasi Saat Pemulangan (Discharge Education)
 - a. Jelaskan diagnosis dan kondisi terkini pasien.
 - b. Jelaskan obat-obatan (nama, dosis, waktu minum, efek samping).
 - c. Jelaskan diet dan pembatasan aktivitas.
 - d. Ajarkan latihan rehabilitasi mandiri bila diperlukan.
 - e. Jelaskan tanda bahaya yang memerlukan kontrol ulang.
 - f. Berikan materi tertulis sebagai panduan di rumah.
 - g. Catat edukasi dalam ringkasan pulang

-
5. Edukasi pada Pelayanan Home Care
 - a. Lakukan asesmen lingkungan rumah.
 - b. Edukasi keluarga tentang pencegahan jatuh dan luka tekan.
 - c. Ajarkan teknik perawatan dasar (memandikan, memindahkan pasien).
 - d. Edukasi kepatuhan terapi dan kontrol rutin.
 - e. Dokumentasikan setiap edukasi dalam catatan kunjungan.

5.3 Media dan sarana Edukasi

1. Leaflet dan booklet geriatri
2. Poster ramah lansia
3. Video edukasi di ruang tunggu
4. Media sosial resmi rumah sakit
5. Modul kelas lansia

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Pelayanan Geriatri ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Tingkat Lengkap di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Penyusunan pedoman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, serta memenuhi elemen standar dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), terutama pada aspek pelayanan berfokus pada pasien, keselamatan pasien, manajemen fasilitas dan keselamatan, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Januari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes